PROTOCOLO DE INVESTIGACIÓN · DOCTORADO EN SALUD PÚBLICA

Organizar la respuesta intersectorial a las necesidades sociales complejas y coocurrentes en atención primaria

Configuración de las redes adaptadas a los distintos perfiles de pacientes atendidos



Eric Bernier, LL.M. y M. Sc.
eric.bernier.1@umontreal.ca · erjb-web.github.io
Doctorado en salud pública · Sistemas, organizaciones y políticas de salud · ESPUM, Université de Montréal

CODIRIGIDO POR LAS
Dras. Nadia Sourial y Géraldine Layani

01 Contexto

Atención primaria en Canadá: 1 de cada 2 pacientes declara una necesidad social · *Kosowan et al., 2025*

19 %
de hogares quebequenses con inseguridad alimentaria en 2023 (14 % en 2018)
ISQ, 2026

40 %
de hogares que gastan la mitad de sus ingresos en vivienda: techo o comida
ISQ, 2026

TRES NOCIONES A DISTINGUIR

La coocurrencia se cuenta; la complejidad se describe; la respuesta intersectorial se organiza en un territorio.

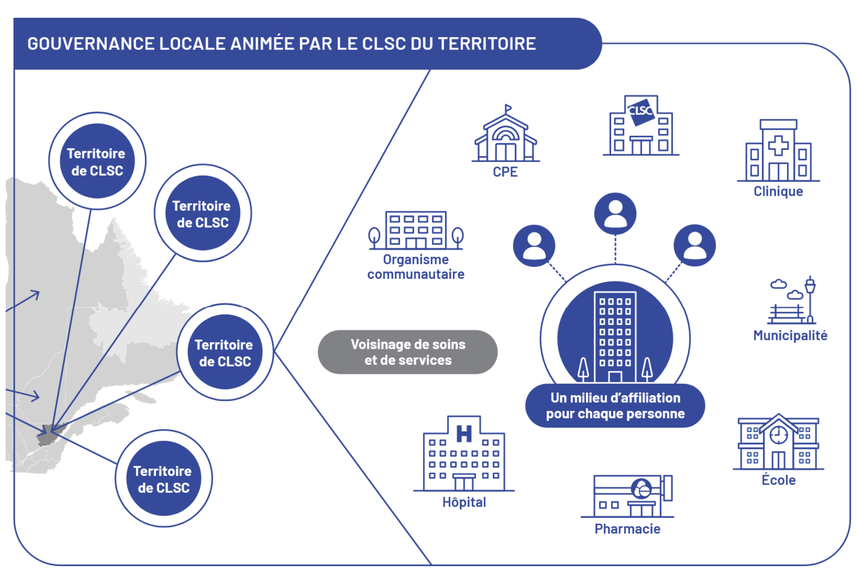
CRITERIO DE INCLUSIÓN
Coocurrencia
Al menos dos necesidades sociales a la vez.
Kreuter et al., 2021

DESCRITA, NO EXIGIDA
Complejidad
Acumulación de enfermedades crónicas, discapacidades, problemas de salud mental y vulnerabilidad social.
Kuluski et al., 2017

SE ORGANIZA EN UN TERRITORIO
Respuesta intersectorial
Acciones de sectores distintos de la salud, realizadas con ella, sobre la salud o sus determinantes: CLSC, hospital, GMF, farmacias, organismos comunitarios, municipio, escuelas, CPE, privado.
MSSS, 2017; Leppo et al., 2013

POLÍTICA DE PRIMERA LÍNEA · MSSS, 2026

El territorio de CLSC: nueva unidad de referencia



CUATRO ROLES DEL CLSC

Navegador · Coordinador · Líder intersectorial · Cofacilitador

«con un espíritu de gobernanza compartida» · MSSS, 2026, p. 42 · esquema: MSSS, 2026

EJEMPLO FICTICIO · HILO CONDUCTOR

MP Sra. Protocolo · 58 años
¿Quién responde? ¿Con quién? ¿Quién coordina?

Aviso de desalojo → Inseguridad alimentaria → Deudas → Depresión (contexto clínico)

EL VACÍO

El CLSC debe coordinar. Pero, para una combinación de necesidades, nada indica qué socios movilizar, cómo vincularlos ni quién coordina. **Se conoce la programación, no las redes realmente constituidas en torno a las trayectorias.**

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Cómo se organiza la respuesta intersectorial para los distintos perfiles de pacientes con necesidades sociales complejas y coocurrentes atendidos en atención primaria?

Meta: vincular cada perfil a… un perfil de necesidades → una configuración de socios → y su coordinador

02 Métodos

Ámbito: 3 territorios de CLSC contrastados en Lanaudière (privación material del 7 % al 50 % según la MRC), región pionera en intersectorialidad (mesa intersectorial) · diseño en varias fases · O2: SNA mixto secuencial explicativo, desplegado desde el CLSC

¿Qué perfiles?

O1 · IDENTIFICAR
Revisión de alcance
4 a 6 viñetas, validadas por 6 a 8 actores

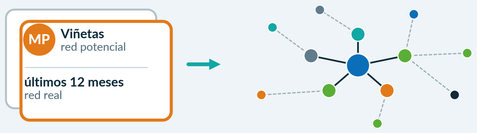
Estudios publicados → Perfiles recurrentes → Viñetas

→ perfiles convertidos en viñetas

MP *Su perfil se identifica en los estudios*

¿Quién moviliza a quién?

O2 · ANALIZAR
Cartografía desde el CLSC
3 CLSC y luego los contactos que nombran



→ redes potenciales y reales

MP *Pasa a ser una viñeta*

¿Por qué y cómo?

O2 · ANALIZAR
SNA cualitativo
15–25 entrevistas · 2–3 trayectorias reales por perfil



→ explicación de las interacciones

MP *Se explica su trayectoria real*

¿Qué recomendar?

O3 · RECOMENDAR
Taller deliberativo
15–20 participantes, con pacientes colaboradores



- Pacientes colaboradores
- Atención primaria
- Comunitario
- Gobernanza local
- Municipal, privado

→ recomendaciones por perfil

MP *Su caso se delibera en el taller*

Integrar

32 meses · 2026 → 2029
Tabla conjunta por perfil

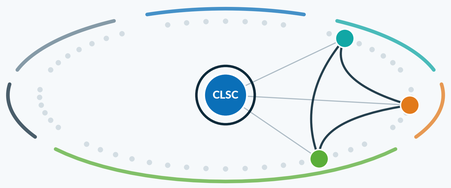
Perfil	Red	Por qué	Rec.
A			
B			
C			

MP *Pautas para su perfil*

03 Resultados esperados

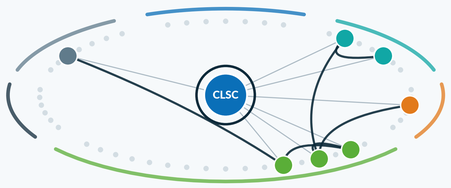
Ejemplos ficticios · **en cada CLSC, la red egocentrada cambia según el perfil**

A Predominio: vivienda
aviso de desalojo



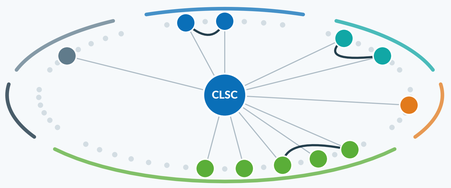
3 socios, todos vinculados · el CLSC coordina

B Sra. Protocolo
vivienda · comida · deudas



7 socios, aún vinculados · el CLSC coordina

C Acumulación + depresión
mismas necesidades, más depresión



11 socios, poco vinculados · sin coordinador

CLSC (ego) · coordinador designado · vínculo declarado por los socios · organización no movilizada
Salud y servicios sociales · Primera línea, farmacias · Comunitario · Municipal · Educación, primera infancia · Empleo, justicia, privado

- H1 **Los sectores cambian** según el perfil → *composición por sector*
- H2 **Un núcleo común,** una periferia propia → *socios comunes*
- H3 **Más socios,** pero menos vinculados → *tamaño y densidad*
- H4 **¿El CLSC navega** y coordina? → *coordinador designado*
- H5 **¿Cambia el género** la respuesta? → *versiones mujer, hombre*
- ≠ **Real o potencial:** ¿qué brecha? → *viñetas vs 12 meses*

04 Impactos y repercusiones

No una «red ideal» universal: pautas para cada perfil.

Para las personas
Una respuesta ajustada a su combinación de necesidades

Para el CLSC y sus socios
Pautas: a quién movilizar, cómo vincularse, quién coordina

Para la política de primera línea
Una línea de base; recomendaciones según los cuatro roles del CLSC

Para la investigación
Una hipótesis perfil–red; la brecha entre redes potenciales y reales

Difusión: devolución a los 3 territorios · protocolo publicado (OSF) · artículos

Todas las versiones: FR · EN · ES · 中文 · العربية · עברית · Innu · daltonismo · baja visión · Lectura fácil · audio

Sus ideas: comentarios · lecturas · contactos

Mi trayectoria: erjb-web.github.io

Referencias: CISSS de Lanaudière, 2024 · Creswell y Plano Clark, 2017 · Gale et al., 2013 · ISQ, 2026 · Kosowan et al., 2025, BMJ Open · Kreuter et al., 2021, Population Health Management · Kuluski et al., 2017, Int J Integr Care · Leppo et al., 2013 · Leutz, 1999 · MSSS, 2017; 2026, política de atención y servicios de primera línea · Peters et al., 2020 · Thorne, 2016